

Cetoacidose diabética · pilares

CAD = hiperglicemia + acidose metabólica com ânion gap + cetonemia/cetonúria. Trate volume e K z com o mesmo rigor da insulina.

Critérios usuais

Dica - Critérios usuais

Glicemia tipicamente > 250 mg/dL, pH < 7,3 ou HCO f < 18, cetonas positivas. Em uso de SGLT2, lembre euglicemic DKA (glicemia pode não estar muito alta).

Use o ânion gap para acompanhar a resolução da cetoacidose; reponha K z antes de 'acelerar' insulina se hipocalemia.

Anion gap e pilares da CAD

Na - (Cl + HCO₃) e sequencia terapeutica

$$AG = Na - (Cl + HCO_3)$$

AG alto + cetonas + glicemia alta = CAD ate prova em contrario

Conduta em 4 passos

- Volume: SF 0,9% inicial; depois ajustar conforme Na corrigido e diurese
- Potássio: se K z < 3,3 mEq/L, repor antes de insulina; se 3,3–5,2, repor junto
- Insulina: infusão EV contínua (ex.: 0,1 U/kg/h) após K z seguro
- Glicose: quando glicemia ~200–250, associar SG para continuar insulina até fechar gap

Resolução — o que observar

Parâmetro | Alvo prático

Ânion gap | Normalização (melhor marcador da cetose)

HCO f / pH | Melhora sustentada

Cetonas | Em queda

Transição SC | Quando comer e gap fechado / clinicamente estável

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Insulina 'empurra' K z para dentro da célula. Iniciar insulina com hipocalemia grave pode precipitar arritmia — reponha K z primeiro.